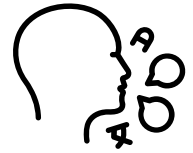


# La prise en soin orthophonique des personnes multilingues vivant avec une aphasie : de l'évaluation à l'intervention



Infographie à destination des orthophonistes

Réalisée dans le cadre du mémoire de Floriane Birraud, étudiante en 5e année d'orthophonie, encadrée par Michèle Masson-Trottier, orthophoniste MPO, SLP(c), PhD

## Objectifs de cet outil



L'objectif de ce matériel est de nous permettre à nous, orthophonistes, de nous sentir davantage outillées pour les prises en soin de personnes multilingues vivant avec une aphasie.

La prise en soins de personnes multilingues peut parfois être intimidante. Nous espérons que la consultation de ce fascicule vous permettre de vous sentir prêtes à vous lancer

Certaines adaptations sont parfois nécessaires ou souhaitables, mais la façon de prendre en soin une personne ne change pas du tout au tout lorsqu'elle est multilingue. Toutes les orthophonistes ayant envie de s'adapter au multilinguisme des patients et qui sont dans une démarche de recherche d'information sont capables de les accompagner.



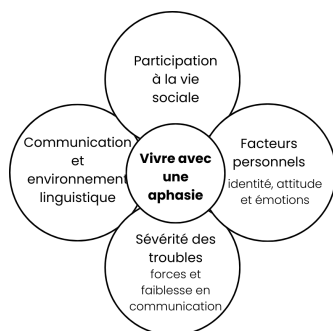
Cet outil a pour but de constituer une boîte à outils qui pourra nous venir en aide lors d'une interrogation précise, correspondant à une section de l'outil, ou sur des interrogations plus globales.

## Structure de l'outil

1. Introduction – la personne multilingue vivant avec une aphasie
2. Éléments à considérer lors d'une première rencontre
3. Évaluation adaptée
4. Intervention orthophonique adaptée
5. Collaboration avec un interprète ou un traducteur

## Cadre théorique

L'élaboration de cet outil est basé sur le modèle du A-FROM et sur la pratique centrée sur la personne.



Le modèle du A-FROM, proposé par Kagan en 2008, permet d'envisager le patient dans sa globalité et dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Le patient vit certes avec une aphasie, mais au-delà de la sévérité des troubles du langage et des symptômes, il faut aussi prendre en compte ses facteurs personnels, sa participation à la vie sociale, sa communication et son environnement linguistique.

Ce modèle nous invite à adapter nos interventions à la demande de la personne prise en soin, ses envies, ses besoins et ses caractéristiques propres, dont le multilinguisme.



C'est dans ses facteurs personnels on peut par exemple retrouver l'importance qu'a chacune des langues pour la personne, que cela soit pour communiquer avec son/sa partenaire, sa famille ou encore suite au désir de reprendre une activité professionnelle. D'autre part, dans le cas des personnes multilingues, la sévérité de l'aphasie pourra varier en fonction de la langue. L'environnement linguistique a aussi son importance, la langue la plus commune dans l'environnement du patient pouvant être la LI du patient et/ou une langue qu'il souhaite récupérer, ou non.

Nos facteurs personnels en tant qu'orthophoniste vont eux aussi influencer l'intervention, notamment en fonction des langues que l'on maîtrise et de notre envie de nous investir dans une prise en soin pouvant sortir de l'ordinaire.

### Alors pourquoi cet outil ?

Et bien, à mesure que les déplacements de population deviennent de plus en plus communs, le besoin de rééducations adaptées linguistiquement et culturellement devient de plus en plus nécessaire. Un nombre croissant de patients pris en soin en orthophonie sont en effet multilingues.

La prise en compte de cette diversité linguistique et culturelle en santé est recommandée par l'OMS mais aussi par le National Institutes of Health (NIH) afin d'améliorer les résultats des prises en soins. Les lignes directrices en orthophonie de plusieurs pays comme l'Australie et l'Irlande mentionnent aussi la nécessité de prendre en compte de la diversité linguistique et culturelle dans le domaine de l'aphasie.

Pourtant, le manque d'accès aux données de ce domaine récent efface parfois l'importance cruciale de prendre en compte cette diversité culturelle et linguistique pour

proposer une intervention adaptée aux besoins de chaque personne. Cet outil rassemble différentes sources d'information scientifiques de ce domaine afin de vous en faciliter l'accès.

# 1) Introduction – la personne multilingue vivant avec une aphasie

## Définitions



Une personne multilingue est une personne qui utilise plusieurs langues au quotidien ou qui est capable de s'exprimer et de comprendre plusieurs langues. Les langues peuvent prendre plus ou moins d'importance dans la vie familiale, sociale et professionnelle de la personne. Bien souvent les différentes langues n'ont pas le même niveau de maîtrise.

Certaines personnes peuvent lire et écrire dans toutes les langues qu'elles maîtrisent, d'autres non (Buschfeld et al., 2019). Il est assez commun de voir des personnes maîtrisant une langue à l'oral uniquement, notamment pour les dialectes ne possédant pas de formes écrites ou pour les langues apprises dans un contexte non scolaire. Cela sera un élément à prendre en compte lors de l'intervention.

Nous parlons aussi bien des personnes habitant dans leur pays d'origine mais ayant besoin de plusieurs langues au quotidien, que celles ayant immigré et qui maîtrise ou non la langue de leur pays de résidence.

La pluralité linguistique sous-entend aussi une pluralité culturelle. A chaque langue peut en effet correspondre des groupes sociaux avec des codes différents et un vocabulaire qui existe ou qui est utilisé dans une langue uniquement.

## Particularités des personnes multilingues



Une personne multilingue est une personne qui utilise plusieurs langues au quotidien ou qui est capable de s'exprimer et de comprendre plusieurs langues. Les personnes multilingues ont la particularité d'avoir pour un même signifié, des représentations phonologiques, des lèmes et des systèmes syntaxiques différents. En revanche, le système sémantique est unique: un même système sémantique est partagé entre les langues. Plus la personne parle de langues, plus les interactions interlinguistiques vont être nombreuses : chaque langue supplémentaire implique en effet un lexique, une grammaire et un tableau phonétique supplémentaires (Buschfeld et al., 2019).

Au niveau du lexique, certaines langues sont plus riches que les autres lorsque l'on se penche sur un domaine lexical particulier. Les possibilités d'agencement de la phrase et les règles d'accord de grammaire sont également plus ou complexes selon les langues. Maîtriser plusieurs langues influence en effet la façon de parler dans chacune de celles-ci.

## Interactions entre les langues

Toujours dans le contexte du multilinguisme, on peut observer deux types de comportement, qu'on va définir comme code switching et code mixing :

Au cours d'une même conversation, une idée peut être dite dans une langue et une autre idée peut être dite dans une autre langue, c'est du code switching (Buschfeld, Ronan et Vida-Mannl, 2023). De même, au sein d'une phrase dans une langue, certains mots peuvent être dits dans une autre langue, soit parce que le mot est plus rapidement accessible, soit parce que la personne ne connaît pas le mot dans la première langue ; c'est du code mixing (Buschfeld, Ronan et Vida-Mannl, 2023).

Ces deux comportements sont fréquents chez les personnes multilingues sans atteinte neurologique et n'enlèvent pas de fluidité à la conversation lorsque les deux partenaires de communication partagent les deux langues (Ansaldi et Ghazi-Saidi, 2011; Buschfeld, Ronan et Vida-Mannl, 2023).

### Particularités du fonctionnement multilingue

Le fait que l'on puisse observer des comportements de code switching ou code mixing chez les personnes multilingues vient du fait que lorsqu'un concept est évoqué, le nombre de mots activés dans le cerveau d'une personne multilingue est plus grand que pour une personne monolingue.



Il faut alors contrôler en permanence quelle langue utiliser en fonction du contexte et inhiber les autres langues connues.

Même lorsque les capacités d'inhibition sont optimales, on retrouve des interactions entre les différents systèmes linguistiques : le coût cognitif est donc plus grand chez les personnes multilingues, dans une tâche de dénomination par exemple.

L'habitude quotidienne à inhiber les langues non visées et à changer de langue pour passer d'un interlocuteur à un autre explique en partie que les personnes multilingues aient souvent des fonctions exécutives plus efficaces que les personnes unilingues (Bialystok et al., 2004; Dash et Joanette, 2016).

On sait aujourd'hui que cet avantage sur le plan des fonctions exécutives entraînerait des aphasies initialement moins sévères chez les personnes multilingues (Paplikar et al., 2018) et que grâce à elles, les personnes multilingues pourraient mieux profiter de l'intervention, même si celle-ci se fait dans une seule langue (Masson-Trottier, 2023). Ces données positives n'écartent cependant pas les situations de handicap dans lesquelles certaines personnes peuvent se trouver, malgré leur fonctionnement cérébral multilingue.

### Et quand la personne multilingue vit avec une aphasie ?

Des code switching et code mixing involontaires peuvent être observés dans certains cas d'aphasie, et auront parfois des conséquences négatives sur la qualité de l'échange.



Ce phénomène peut mettre en évidence une activation parallèle de la représentation phonologique de l'item dans la langue visée et dans les autres langues connues. Les orthophonistes prenant en soin des personnes multilingues vivant avec une aphasie peuvent être témoins de ces comportements ; il conviendra alors de se renseigner auprès du patient ou de ses proches, afin de savoir si ces changements de langues sont socialement inhabituels, et donc pathologiques, ou non.

Pour mieux comprendre les comportements linguistiques des personnes multilingues, il est intéressant pour nous, orthophonistes, d'avoir une curiosité linguistique ou des connaissances dans d'autres langues que la sienne pour pouvoir reconnaître des erreurs caractéristiques que l'on peut retrouver chez des personnes multilingues sans trouble de la communication, comme les erreurs dans l'utilisation des prépositions, l'utilisation de mots moins précis, ou le mélange de syntaxe entre les langues.

Nous pouvons clôturer cette section en rappelant que pour tous les patients vivant avec une aphasie, la participation sociale est considérablement réduite. Pour favoriser au maximum la participation sociale des personnes multilingues, il est nécessaire de rechercher les progrès dans toutes les langues. La prise en soin des patients dans la langue du pays de résidence uniquement, sans considération pour leur multilinguisme, n'est en effet pas toujours le choix le plus pertinent pour minimiser le retentissement de l'aphasie au quotidien.

Lorsque nous ne parlons qu'une seule langue ou que nous ne partageons pas les mêmes langues que notre patient, il existe des stratégies pour travailler les autres langues parlées par le patient afin de favoriser le retour de sa participation sociale dans les différents groupes culturels et linguistiques dont il fait partie.

## 2)Eléments à considérer lors d'une première rencontre

### L'anamnèse



Commençons par l'anamnèse. En plus des questions habituelles de prise en soin, il est essentiel de s'informer sur l'âge et le contexte d'acquisition de chacune des langues parlées par la personne, son exposition aux différentes langues au cours de sa vie et à l'heure actuelle et quel genre d'utilisation des langues la personne a.

### Le choix du vocabulaire

Comme dans tout type de prise en soin, nous pouvons utiliser des stratégies pour limiter les moments où la personne accueillie se sentirait en situation de handicap de communication, lors de l'anamnèse mais aussi tout au long de la prise en soin. D'abord, une attention particulière doit être portée à l'emploi d'un jargon orthophonique auprès de tous les patients vivant avec une aphasie, mais encore plus dans le contexte de personnes multilingues. En effet, un patient multilingue peut parler votre langue d'usage comme langue seconde et être à l'aise dans cette langue sans pour autant comprendre le vocabulaire médical et/ou les mots relatifs aux interventions en orthophonie.

En santé, il est d'ailleurs conseiller de considérer que le patient et ses proches peuvent ne pas comprendre tout ce qu'expliquent les professionnels (Koh et Rudd, 2015).



C'est d'autant plus vrai dans le contexte de multilinguisme : les proches peuvent ne pas maîtriser suffisamment la langue que nous parlons pour comprendre le vocabulaire médical. Les proches risquent alors de se retrouver eux aussi dans une situation de handicap de communication.

### Faciliter la compréhension

La communication multimodale, aussi appelée communication totale peut aussi être appréciée par les patients : cela consiste à compléter le langage oral par des signes, des dessins, des tableaux de communication ou le partage de documents imagés. Ces adaptations pourront également être utiles pour les proches s'ils maîtrisent peu la langue que nous parlons.



La communication multimodale est pertinente à utiliser en orthophonie, au delà du multilinguisme et du monde de l'aphasie.



Enfin, passer par l'écrit pour résumer les points clés du bilan ou de la séance peut être également être une bonne idée. Cet écrit doit comporter au maximum trois points, et ne pas utiliser de jargon {Hildenbrand, 2020 #65}. Des phrases courtes et simples sont plus adaptées, notamment dans le cas où ces phrases auraient besoin d'être traduites en ligne, plus les phrases seront simples, plus la traduction proposée sera précise.

Il convient néanmoins de garder en tête que l'écrit, est une modalité plus sensible qui peut mettre du temps à être récupérée, qui peut donc ne pas être adaptée à toutes les personnes. Cependant, même dans les cas où la personne a des difficultés de lecture de paragraphes par exemple, elle peut parfois comprendre les points que nous pourrions écrire avec des phrases courtes ou des mots uniques. L'écrit a aussi l'avantage d'être permanent et de permettre à la personne de prendre le temps dont elle a besoin pour prendre connaissance des informations.

Ce résumé peut être écrit pendant la séance avec la personne peut nous permettre de personnaliser nos interventions et de ralentir notre parole. Si besoin cet écrit peut être compléter par des schémas ou images.

### **Le recours à un interprète**

Globalement, il faudra s'assurer que les informations soient bien comprises. Dans un contexte multilingue, le recours à un interprète pourrait être nécessaire ou souhaitable pour que le patient et son entourage prennent des décisions éclairées sur les objectifs de rééducation, et ce même lorsque le patient et nous partageons une langue ou que des stratégies de communication, comme celles évoquées précédemment sont utilisées.

Des difficultés de communication peuvent en effet être ressenties lors de notre intervention, indépendamment le niveau de maîtrise des langues par la personne. Même lorsque la personne maîtrise très bien la langue que nous parlons certains mots peuvent être inconnus et nécessiter une reformulation.

Le recours à un interprète est une façon de réduire les disparités entre les patients maîtrisant bien la langue d'usage du pays et les autres (Larkman et al., 2022).

### **La posture de l'orthophoniste**

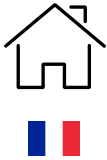


Ressentir que nous sommes dans une posture ouverte et prête à s'ajuster constamment pourra permettre à la personne de se sentir plus écoutée.

Lui donner l'occasion de nous parler d'aspect de la langue relatifs à sa culture montrera une nouvelle fois notre envie de prendre en soin la personne dans sa globalité et nous fournira des informations précieuses pour la suite de la rééducation.

---

## Cas clinique : Sarah



Sarah a 66 ans et vit à Bordeaux avec sa compagne française et leurs deux chats, June et Mistigri.



Sarah est née à Juneau (Alaska) d'une mère mexicaine et d'un père américain. Sarah a grandi en parlant espagnol avec sa maman et anglais avec son papa. Elle a été scolarisée en anglais uniquement et a également appris à lire et écrire en espagnol en allant à deux heures de cours hebdomadaires pendant son adolescence. .

Sarah a commencé à apprendre le français à 18 ans, à l'université. C'est lors d'un semestre en France qu'elle a rencontré sa compagne actuelle. Elles ont d'abord habité aux Etats-Unis pendant 30 ans puis ont déménagées en France depuis plus de 15 ans. Sarah, maintenant en retraite, était responsable des ventes d'une entreprise mexicaine sur le territoire américain. Elle a toujours travaillé en télétravail, en anglais avec ses clients et en espagnol avec ses collègues et managers. Aujourd'hui et depuis maintenant 46 ans Sarah parle 50% anglais et 50% français avec sa compagne. Les amis du couple sont majoritairement anglophones.

Sarah parle donc trois langues et possède ainsi le vocabulaire et la phonologie associée en français, espagnol et anglais.

Les champs lexicaux de Sarah ne sont pas les mêmes dans toutes les langues : Sarah a appris à cuisiner avec son papa en anglais, elle connaît peu de vocabulaire culinaire dans les deux autres langues, elle suit les actualités en espagnol uniquement. Elle a commencé à prendre des cours de peinture en français il y a six ans. Ce lexique spécifique est développé en français uniquement.

Il peut arriver que Sarah ait des moments de code switching et de code mixing : Par exemple, dans une conversation en anglais Sarah commence parfois à parler français lorsqu'elle évoque son atelier de peinture. Les code switching ne posent pas problème au sein du couple puisque la compagne de Sarah comprend l'anglais et le français.

Il arrive aussi fréquemment que Sarah fasse des code mixing, en disant certains mots en anglais dans une phrase française, soit parce que le mot est plus rapidement accessible, soit parce qu'elle ne connaît pas le mot en français.



Il y a huit mois, Sarah a fait un AVC dans l'hémisphère gauche, qui a provoqué une aphasie non fluente avec une anomie modérée et une hémiparésie droite. Elle a été hospitalisée quatre mois en service de "Soins de Suite et Réadaptation". Depuis sa sortie de l'hôpital elle n'a pas encore trouvé d'orthophoniste.

Le cas de Sarah sera notre cas clinique pour illustrer cet outil d'information pour la prise en soin des personnes multilingues, qui comme Sarah, vivent avec une aphasie.

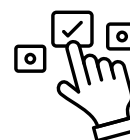
## **Éléments à considérer lors d'une rencontre**

Lors de la première rencontre avec Sarah et pendant toute la prise en soin, nous veillerons à utiliser un vocabulaire adapté.



Sarah, maîtrise assez le français pour faire une partie (ou la totalité) de la rééducation en français. Mises à part les conséquences de l'aphasie, la communication avec elle sera possible. Cependant, le français n'est pas sa langue maternelle, Sarah est très peu à l'aise avec le vocabulaire médical en français, elle pourra apprécier avoir des explications dans une de ses deux langues maternelles : en anglais ou en espagnol, grâce à un interprète.

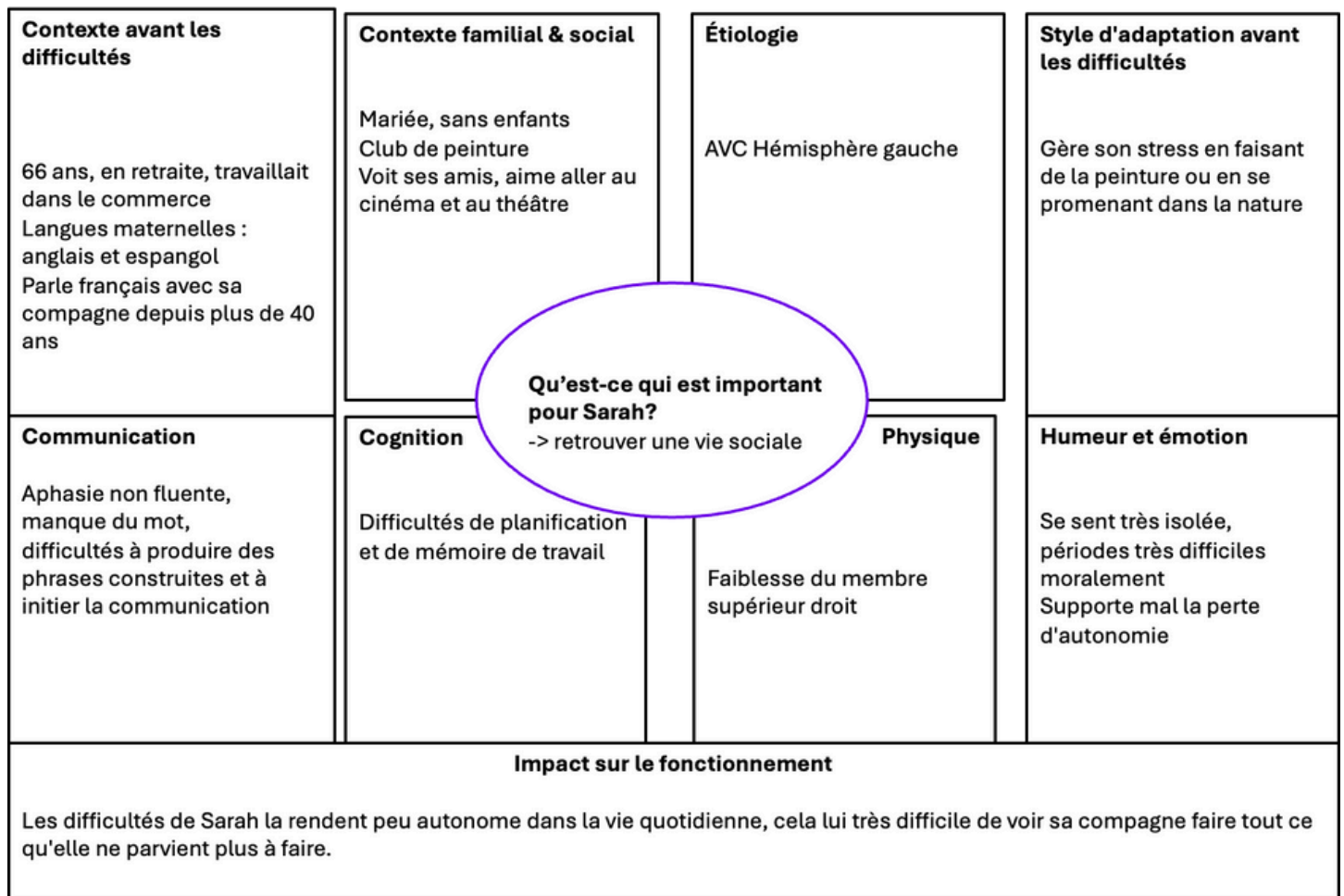
D'autre part, dès la première rencontre, avec Sarah, il est essentiel de l'impliquer dans le choix des objectifs de rééducation et de notamment lui demander quelles langues elle souhaite récupérer. Des facteurs personnels peuvent être à l'origine d'une préférence de rééducation. Une personne proche de la retraite souhaitant retourner dans son pays d'origine ne souhaitera peut-être pas travailler dans la langue du pays de prise en soin. Au contraire, une personne n'ayant plus de contact avec sa famille n'aura peut-être pas envie de récupérer sa langue maternelle.



Sarah, elle, utilise encore quotidiennement ses trois langues, elle souhaite donc récupérer ses capacités dans les trois langues.

## **Qu'est ce qui est important pour Sarah ?**

Lorsque l'on commence la prise en soin d'une personne nous pouvons compléter ce genre de tableau pour avoir une vue d'ensemble de son profil.



Source: Formation ICAP par Farrington-Douglas, Rutter, 2023, Adapté par Michèle Masson-Trottier

Sarah a 66 ans, elle est en retraite, elle travaillait auparavant dans le commerce. Sarah a deux langues maternelles : l'anglais et l'espagnol, qu'elle pratique toujours quotidiennement ; et a commencé à apprendre le français à 18 ans et a toujours continué à le pratiquer depuis, avec sa compagne française.

Sarah est mariée et n'a pas d'enfants. Elle va dans un club de peinture une fois par semaine. Elle voit ses amis régulièrement et aime sortir au cinéma et au théâtre.

Son aphasie fait suite à un AVC dans l'hémisphère gauche.

Avant l'AVC, Sarah avait l'habitude de gérer son stress en faisant de la peinture ou en se promenant dans la nature.

Les difficultés de communication se manifestent essentiellement par un manque du mot, une difficulté à produire des phrases construites et à initier la communication.

Depuis son AVC, Sarah est très fatigable et a des difficultés de planification et mémoire de travail.

Sarah a bien récupéré de son hémiparésie droite, une faiblesse du membre supérieur persiste.

Sarah se sent très isolée depuis son AVC, elle décrit des périodes très difficiles moralement et a supporté mal d'être assistée pour tout

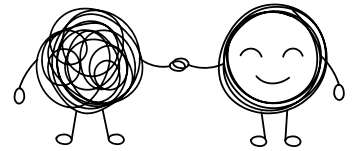
Impact sur fonctionnement : les difficultés de Sarah la rendent peu autonome dans la vie quotidienne, cela lui est très difficile de voir sa compagne faire tout ce qu'elle ne parvient plus à faire.

La chose la plus importante pour Sarah est de retrouver une vie sociale.

---

## **A l'issue de la rencontre avec une personne multilingue vivant avec une aphasie**

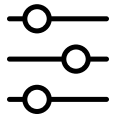
A l'issue de la première ou des premières rencontre(s), il sera utile de résumer les forces du patient et les déficits à surmonter. Il est en effet important de savoir ce qui est préservé pour pouvoir s'appuyer sur les capacités résiduelles de la personne et savoir ce que la personne veut faire mais ne peut plus faire pour choisir ensemble des objectifs.



En tant qu'orthophoniste, notre objectif sera de réduire l'écart entre ce que la personne peut faire et veut faire.

Pour que Sarah puisse retrouver une vie sociale, en allant à son cours de peinture par exemple, un objectif pourra être tourné vers la participation à une discussion courte et simple pour prendre des nouvelles.

### 3) Evaluation



L'évaluation d'une personne multilingue ayant une aphasie est similaire à l'évaluation d'une personne unilingue, mais comporte des particularités. En effet, bien que les dimensions linguistiques à évaluer soient les mêmes, d'un point de vue éthique et clinique, il est nécessaire d'évaluer une personne multilingue dans l'ensemble des langues qu'elle maîtrise afin d'avoir un aperçu le plus complet possible de ses capacités et de ses déficits.

#### **Comment évaluer ?**

Les épreuves à proposer et les domaines à évaluer ne varient pas de celles pouvant être proposées à un patient unilingue. D'abord, une évaluation recherchant une aphasie doit, par définition, rechercher une anomie. Celle-ci peut toucher les noms et les verbes, de façon distincte ou non et touche fréquemment les différentes langues parlées, cependant celle des verbes peut être plus prégnante dans les langues secondaires du patient (Mejuto, 2018). Cette observation serait en lien avec des liens plus faibles entre les représentations phonologiques et sémantiques des langues acquises plus tardivement ou dans un contexte moins écologique.

Ensuite, pour tous les patients multilingues, il est pertinent de caractériser les erreurs en y intégrant la possibilité de bonne réponse dans la langue non visée. A titre d'exemple, Ansaldi, Saidi et Ruiz (2009) utilisent quatre catégories d'erreurs lors de la passation de la WAB (Western Aphasia Battery) dans une étude de 2009 : (a) Changement de langue (*Language Switching*), (b) Dénomination retardée (*Delayed Naming*), (c) Anomie (*Anomia*) et (d) Tâtonnement (*Groping Behaviour*) (Ansaldi, Saidi et Ruiz, 2009).



La description de ces comportements peut nous guider lors du bilan. Pour finir, lors de l'évaluation comme de l'intervention, nous devrions toujours considérer les aspects conservés de la langue non traitée comme des points d'appui, d'où l'intérêt d'évaluer les personnes dans toutes les langues qu'elles maîtrisent.



Il est intéressant de se renseigner sur les langues maîtrisées par la personne prise en soin, une orthophoniste sensibilisée à une langue pourrait obtenir des indices supplémentaires concernant les capacités du patient en reconnaissant certains mots venant de celle-ci lors d'une épreuve ou un exercice où l'on attendait une réponse dans une autre langue.

#### **Avec quoi évaluer ?**

Plusieurs outils permettent l'évaluation dans de nombreuses langues. Pour la BAT, il est recommandé que chaque version du bilan soit administrée par un locuteur natif de la langue testée (Siyambalapitiya et Davidson, 2015). Cela peut être l'orthophoniste ou un proche ou un interprète guidés par l'orthophoniste.

Pour obtenir des résultats précis, il est aussi nécessaire d'utiliser des normes adaptées à chaque groupe linguistique et culturel. Par exemple, pour Sarah les normes mexicaines à un test seront nettement plus significatives que les normes espagnoles, alors même que le test sera dans les deux cas en espagnol. Les variations linguistiques entre les pays hispanophones sont grandes.

Lorsqu'aucune batterie multilingue ou test standardisé n'est disponible dans la langue souhaitée, la traduction des tests de bilan est un bon début mais ne garantit pas de préserver une difficulté similaire au test proposé dans la langue d'origine (Paradis 2011). L'idéal est plutôt d'adapter le contenu tant au niveau linguistique que culturel, pour qu'il reste équivalent au test initial en termes de difficulté (Lorenzen et Murray, 2008).



Tester les patients dans certaines langues ou certains dialectes semble très difficile, c'est cependant ce vers quoi il faut tendre afin d'éviter la non prise en compte du multilinguisme d'une personne parce que l'orthophoniste ne maîtrise pas certaines langues.

Dans le cas des évaluations adaptées nous-mêmes, avec ou sans aide d'un proche ou d'un interprète, celles-ci ne seront alors pas étalonnées et doivent être interprétées avec précaution.

## **Evaluation globale du patient**

Outre l'évaluation du langage, les fonctions exécutives, la mémoire et l'attention doivent également être évaluées. Ces domaines rappellent la pertinence d'une prise en soin et d'une collaboration pluridisciplinaire.

L'expertise d'un neuropsychologue peut notamment être très utile. Lorsqu'une évaluation neuropsychologique n'est pas possible, il existe aussi des tests pouvant être proposées par les orthophonistes permettant d'avoir un aperçu global des possibilités de la personne. Dans ce cas, il est utile de savoir qu'il est possible d'utiliser les normes monolingues des tests neuro-cognitifs avec les patients multilingues. Aucune différence significative de niveau n'a été montrée entre les personnes multilingues et les autres. Les études rappellent cependant la nécessité de considérer les code mixing et code switching comme bonnes réponses pour scorer les tests neurocognitifs qui nécessiteraient une réponse verbale.

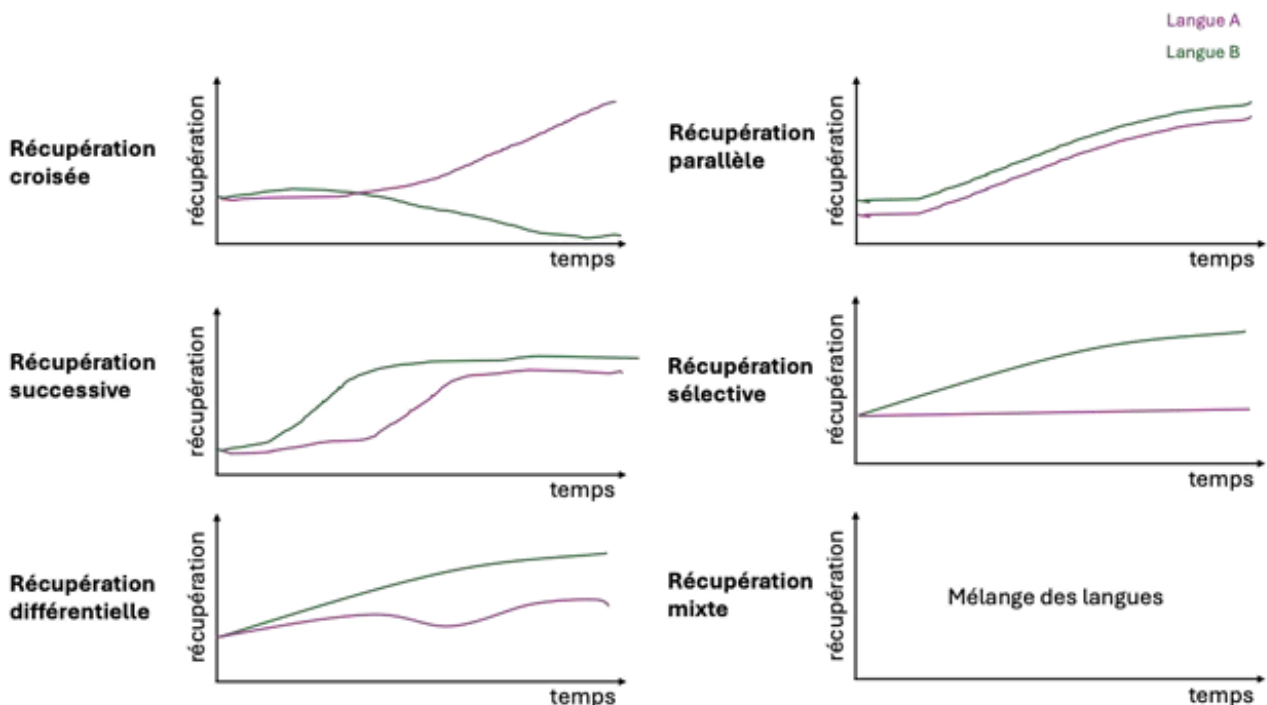
---

Sarah a déjà fait un bilan neuro-cognitif avec une neuropsychologue, nous n'aurons donc pas besoin de la tester sur ce point. Nous savons qu'elle a des difficultés de planification

et mémoire de travail. Ses capacités d'inhibition sont bonnes, cette information aura son importance pour la suite.

## 4) Intervention

### Récupération



A la suite d'une aphasie, la trajectoire de récupération des différentes langues maîtrisées par le patient sera très variable d'une personne à l'autre. (Kiran et Roberts, 2012). Que ces différentes langues soient maîtrisées au même niveau avant son accident ou non, cette situation peut être tout autre après une aphasie. La langue la mieux maîtrisée avant l'accident peut ne pas être la même après.

Différents schémas de récupération sont possibles (Köpke, 2013; Lorenzen et Murray, 2008) :

- la récupération parallèle, où les différentes langues sont récupérées simultanément
- la récupération sélective, où une seule langue est récupérée et l'autre ne l'est jamais.
- la récupération successive, où une langue est améliorée avant l'autre.
- la récupération croisée/antagoniste, où une langue commence à être récupérée puis les progrès s'effacent, au profit d'une autre langue.
- la récupération différentielle, où les différentes langues commencent à progresser en même temps mais pas au même rythme.
- la récupération mixte, où les différentes langues se mélangent (codes switching/mixing pathologiques)

A l'heure actuelle, les données sur les différents types de récupération sont seulement disponibles concernant les aphasies bilingues. Dans le contexte multilingue, on peut

s'attendre à ce que la récupération soit similaire à ce qui est décrit ci-dessus, voire un peu plus complexe.

Peu d'informations sur la manière d'adapter nos interventions en fonction des profils de récupération sont disponibles. Lorsqu'une prise en soin commence, l'orthophoniste peut tout de même tenter d'identifier le profil de récupération qui semble apparaître chez la personne prise en soin afin d'ajuster son intervention selon les objectifs de la personne, notamment en réaxant le travail sur une langue plutôt qu'une autre par exemple. En effet, le profil de récupération varie notamment en fonction de si l'intervention est faite dans une ou plusieurs langues.



L'aidant principal peut nous fournir des informations précieuses sur les progrès observés dans les différentes langues, notamment dans celles que nous ne maîtrisons pas.

Avec Sarah, si nous choisissons de travailler les trois langues qu'elle maîtrise, il y a plus de chances que celles-ci progressent, que cela soit de manière homogène ou non.

## Généralisation translinguistique

La généralisation trans-linguistique est possible en travaillant une seule langue, bien qu'elle ne soit pas systématique : par exemple si l'on travaille en français avec Sarah, nous pouvons espérer des progrès en anglais et/ou en espagnol mais cela n'est pas garanti.



Les schémas de récupération et de généralisation de la langue traitée à la langue non traitée dépendent, entre autre, de la distance lexicale et orthographique entre les deux langues. Le français et l'espagnol ayant plus de similarités dans les racines des mots et l'ordonnancement des phrases, la généralisation pourra être favorisée.

La littérature met en évidence une généralisation translinguistique dans environ la moitié des cas de rééducation d'aphasie multilingue (Lerman, Edmonds et Goral, 2018). Ce processus dépend de plusieurs facteurs et peut concerner une tâche unique ou se généraliser plus largement.

Dans la majorité des cas, une intervention dans la L1 du patient résultera en une meilleure récupération qu'une intervention en L2, mais permettra moins de généralisation translinguistique (Edmonds et Kiran, 2006; Lorenzen et Murray, 2008). Au contraire, travailler la L2 pourrait avoir plus de bénéfices pour faciliter la généralisation translinguistique qu'en travaillant la L1 (Edmonds et Kiran, 2006).



Cela serait dû aux liens sémantiques plus forts des L2 vers la L1 : dans le cas d'un multilinguisme consécutif, les L2 sont construites en prenant la L1 comme référence. Pour Sarah, le français a été construit en prenant comme référence l'anglais et l'espagnol.

D'autre part, un multilinguisme équilibré, c'est à dire lorsque les différentes langues sont au même niveau de maîtrise, contribue à la généralisation translinguistique (Ansaldi et Saidi, 2014). D'autre part, la langue à laquelle le patient est exposé après son AVC a une grande influence sur la récupération, qui peut être facilitée par une exposition quotidienne (Goral et Lerman, 2020). Ainsi, s'il n'est pas possible d'offrir une intervention dans la L1 d'un patient, une intervention dans une langue à laquelle le patient est exposée quotidiennement pourrait aussi permettre d'observer une récupération significative.

### **Prise en soin**

Si la personne prise en soin souhaite récupérer une langue que nous ne maîtrisons pas, une prise en soin "classique" peut être proposée en ayant des considérations pour stimuler la langue souhaitée, grâce à un traducteur ou grâce aux outils technologiques par exemple. Nous développerons cela dans la suite de l'outil.

De même, lorsque les différentes langues sont travaillées en même temps, il existe plusieurs façons de procéder.

Les personnes multilingues vivant avec une aphasie peuvent avoir des déficits langagiers influencés par des anomalies au niveau des processus d'activation et/ou d'inhibition des langages (Goral et Lerman, 2020). Le modèle Treatment Effects in Aphasia in Multilingual people (TEAM) proposé par Goral et Lerman (2020) permet d'expliquer les interactions entre les différents domaines à prendre en compte lors d'une intervention avec une personne multilingue vivant avec une aphasie. Le modèle TEAM permet de prendre tous ces facteurs en considération et de mieux comprendre l'influence du type d'intervention selon le profil de récupération du patient.

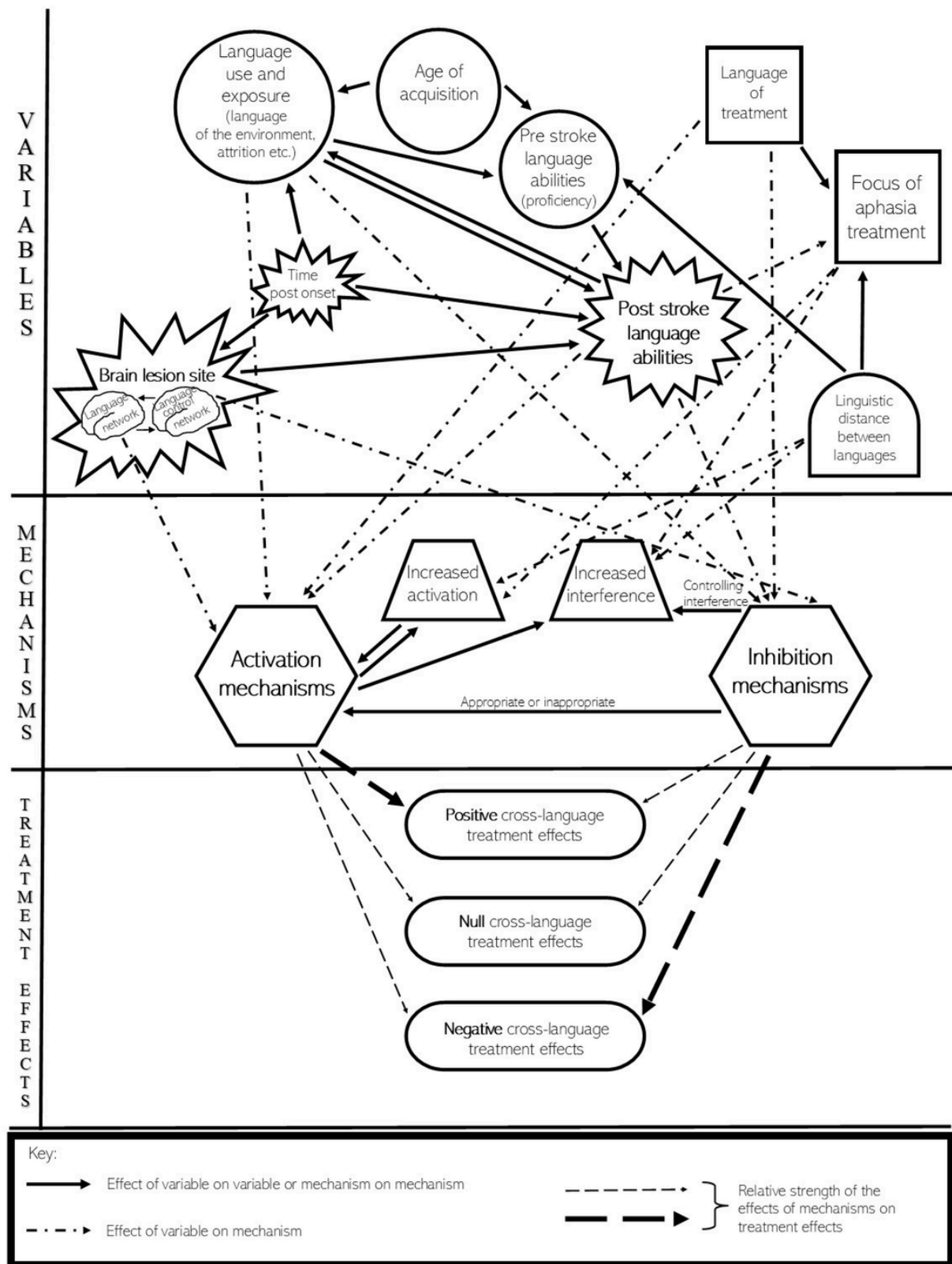
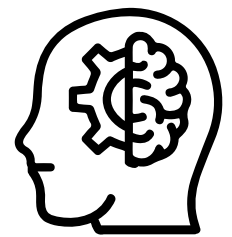


Figure tirée de (Goral et Lerman, 2020) représentant un modèle intégré des effets du traitement de l'aphasie chez les personnes multilingues (TEAM) illustrant l'interaction des variables et des mécanismes influençant les effets interlinguistiques après un traitement chez les personnes multilingues vivant avec une aphasie.

## Impact des fonctions exécutives sur le choix d'intervention

Le choix d'intervenir dans une ou plusieurs langues variera en fonction du degré d'atteinte des fonctions exécutives, en lien avec les capacités d'activation ou d'inhibition des différentes langues, comme le montre le modèle TEAM (Goral et Lerman, 2020).

Si le patient montre des faiblesses au niveau des fonctions exécutives, l'orthophoniste pourrait privilégier une intervention dans une seule langue en espérant une généralisation translinguistique, puis cibler une autre langue ensuite et espérer un type de récupération successive. Le travail de plusieurs langues simultanément pourrait en effet faire diminuer les progrès dans certaines langues pour accorder toutes les ressources cognitives à la langue travaillée.



De même, observer une récupération croisée, ou le déclin d'une langue lorsqu'une autre est travaillée, peut nous interroger sur l'intégrité des fonctions exécutives. Il faudra alors contourner cette activation antagoniste en évitant par exemple de travailler des cognates. Les cognates sont des mots qui partagent une racine commune entre deux langues et qui ont donc une enveloppe phonologique similaire (Ansaldi, Saidi et Ruiz, 2009; Goral et Lerman, 2020; Kohnert, 2009) (par exemple "crème" en français, "cream" en anglais et "crema" en espagnol). L'utilisation des cognates implique des recherches préalables sur les langues parlées par le patient.

Au contraire, lorsque les fonctions exécutives sont bien préservées, il est possible de proposer une intervention dans plusieurs langues. Celles-ci peuvent être travaillées simultanément ou une par une en fonction de l'habitude du patient. Pour les personnes utilisant leurs différentes langues dans différents contextes, il semblerait que travailler les langues une par une aurait de meilleurs résultats que travailler toutes les langues simultanément. La langue travaillée peut changer entre les séances ou au sein de celles-ci. Cette démarche permettrait de réduire les code-switching involontaires. Au contraire, si le patient ou ses proches nous informent qu'il est socialement habituel de mélanger les langues, il sera plus écologique de travailler ces langues simultanément et de ne pas reprendre le patient lorsqu'il change de langues au cours d'une phrase ou d'un exercice.

---

Pour Sarah, qui a l'habitude de mélanger l'anglais et le français et qui n'a pas de difficultés d'inhibition suite à son aphasie, nous pourrions travailler les différentes langues en même temps et utiliser des cognates.

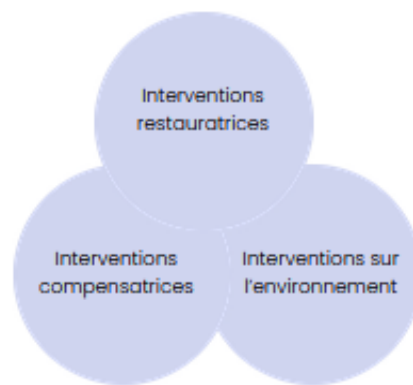
---

## **Types de prise en soin**

Il existe plusieurs types de prises en soin de personnes multilingues ; l'important est d'adopter une intervention centrée sur la personne et de s'adapter à la personne qui reçoit l'intervention : la personne devant nous n'est pas unilingue, la prise en soin ne peut donc pas être la même que pour une personne unilingue, et ce même si nous choisissons de travailler dans une seule langue.

D'autre part, comme pour tout type de patientèle la prise en soin proposée va varier d'un patient multilingue à l'autre. Chaque personne est différente, ses possibilités et besoins aussi.

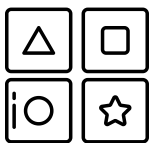
Le diagramme ci- dessous regroupe les interventions habituelles qui peuvent être proposées dans le domaine de l'aphasie, dans une seule langue, dans différentes langues simultanément, ou dans une langue après l'autre.



On retrouve les interventions restauratrices, qui, en fonction des cas, peuvent cibler l'anomie, la compréhension, la morphosyntaxe, etc ; les interventions compensatrices qui consistent en la mise en place de stratégies de communication et/ou de clarification, avec notamment l'utilisation de la CAA ; et les interventions qui ciblent l'environnement grâce à un travail en partenariat avec les partenaires de communication.

Passons maintenant à quelques exemples de méthodes et stratégies pouvant être utilisée avec des personnes multilingues vivant avec une aphasie. Cet aperçu non exhaustif ne nie en rien l'efficacité d'autres thérapies. La majorité des interventions restauratrices ont été développées pour des personnes unilingues et ont été par la suite étudiées chez des populations multilingues. Nous allons développer différentes sections sur les interventions ciblant la dénomination, la syntaxe, le discours et les fonctions exécutives.

### **Intervention ciblant la dénomination**



La thérapie Semantic Feature Analysis (SFA) (Boyle, 2004) est un exemple de thérapie qui a d'abord été développée pour des personnes unilingues vivant avec une aphasie pour travailler la dénomination, puis étudiée auprès de personnes multilingues (Kiran et Roberts, 2009).

Selon l'étude de Kiran et Roberts (2009), avec un travail en SFA, une généralisation entre trois langues est possible des items travaillés aux items sémantiquement liés. Lorsqu'on travaille la dénomination, le choix des items travaillés est important. Les items travaillés étant les mieux récupérés, choisir des items fonctionnels pour la personne permettra minimiser le retentissement de l'aphasie dans son quotidien (Lee et Farooqi Shah, 2024). La fréquence des items travaillés et leur imageabilité ont aussi un impact sur la généralisation translinguistique (Goral et Lerman, 2020) : plus ils sont fréquents et imageables plus la généralisation entre les langues est courante (Lerman, Edmonds et Goral, 2018).

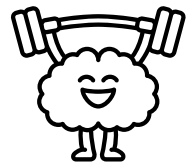
La thérapie Abstract Semantic Associative Network Training (AbSANT) qui est une version de la thérapie SFA qui permet de travailler des mots plus abstraits et la Verb Network Strengthening Treatment (VNest) qui cible la production de verbes sont deux autres possibilités pour travailler la dénomination.

Plus généralement, proposer des exercices sémantiques permet de faciliter l'accès au lexique des items entraînés mais aussi au lexique de ceux en lien, et cela dans différentes langues (Kiran et Roberts, 2009). Le système sémantique est en effet commun à toutes les langues : en travaillant un même signifié, plusieurs signifiants pourront être activés, et éventuellement récupérés.

### *Focus sur la thérapie Switch Back Through Translation*

Lorsque la personne a tendance à changer de langue sans s'en rendre compte, la thérapie Switch Back Through Translation (SBTT) peut être pertinente.

Cette thérapie, développée par l'équipe d'Ansaldi et Ghazi-Saidi (2011), ne vise pas l'inhibition de la langue non visée par l'exercice, mais plutôt son utilisation comme stratégie compensatrice dans les cas où la réponse ne vient pas dans la langue visée, rendant ainsi le discours plus fluide. Le patient peut, dans le contexte de cette thérapie, utiliser la langue qui lui vient spontanément. Lorsque le patient répond dans la langue non visée, nous pouvons utiliser une petite phrase du type «ce qui veut dire...» pour que le patient traduise et revienne à la langue travaillée (Ansaldi, Saidi et Ruiz, 2009). Cette petite phrase sera dite dans la langue visée et pourra être progressivement remplacée par un geste ou une expression du visage.

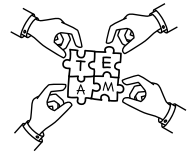


Ainsi, le patient utilise la traduction, préservée, pour contourner la dénomination qui est atteinte. A terme, cette stratégie vise l'autonomie du patient à se rendre compte du changement de langue et à revenir à la langue souhaitée.

### *Stratégies pour faciliter le travail de l'anomie dans une langue que nous ne maîtrisons pas*

Pour terminer, il existe des stratégies pour faciliter le travail de l'anomie dans une langue non maîtrisée par l'orthophoniste comme l'utilisation des outils technologiques comme la dictée vocale de Google Traduction ou de Rerverso pour produire le mot correspondant à l'item à désigner ou pour constituer un exemple de prononciation pour l'orthophoniste elle-même.

Offrir aux proches l'opportunité de participer aux interventions notamment pour vérifier la réponse du patient ou pour lui donner la bonne réponse d'un mot à dénommer peut faciliter grandement le travail dans les différentes langues. Il est important de clairement expliquer au proche que l'idée n'est pas qu'il devienne un intervenant, mais plutôt qu'il participe aux interventions.



## **Intervention ciblant la syntaxe**

Au niveau syntaxique, une généralisation translinguistique survient plus facilement pour les aspects syntaxiques partagés entre les différentes langues (Goral et Lerman, 2020).



Lors du travail de la production ou de la compréhension de phrases, il est intéressant de vérifier si les langues parlées par le patient partagent la même structure pour les phrases basiques. Cette vérification nous permettra de mieux comprendre les éventuelles erreurs commises. Les études divergent cependant sur l'impact de la distance entre les langues sur la généralisation (Ansaldi et Saidi, 2014).

Nous devons alors procéder par essai-erreur afin de proposer des types de phrases le plus adapté possible au profil de la personne prise en soin. Sachant cela, différentes possibilités s'offrent à elle pour travailler la syntaxe.

*Stratégies pour faciliter le travail de la syntaxe dans une langue que nous ne maîtrisons pas*



Concernant les stratégies pour faciliter le travail de la syntaxe dans une langue que nous ne maîtrisons pas, il est par exemple possible d'utiliser des enregistrements vocaux dans la langue visée pour qu'ils servent d'exemple de phrases bien construites ou pour que nous puissions prendre exemple et répéter des phrases dans une langue que nous ne connaissons pas.

Ces enregistrements vocaux peuvent être faits par un interprète ou un proche de la personne prise en soin, avec des phrases conseillées par le proche et/ou préalablement choisies par le patient et nous. Ce support peut également permettre au patient de s'entraîner chez lui, seul ou avec ses proches.

## **Intervention ciblant le discours**

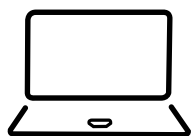
Travailler le discours se révèle pertinent, en effet le travail dans une langue peut permettre une amélioration dans les autres langues, et ce même si aucune amélioration n'est relevée dans la langue traitée (Lerman, Edmonds et Goral, 2018).

Ensuite, travailler la production de phrases, à l'aide d'un outil numérique ou non, est efficace pour l'amélioration du discours mais également pour faciliter la récupération des mots en mémoire et de la grammaire (Grasso et al., 2019). L'outil Video Implemented Script Training for Aphasia (VISTA) consiste en l'utilisation d'un script vidéo pour améliorer la production et la fluence de la parole dans les différentes langues. Cet outil donne au patient un modèle vidéo. Il est important que nous choisissons des scripts adaptés dans leur vitesse et leur complexité linguistique, tout en veillant à ce que le patient soit intéressé par le sujet abordé. Le patient et ses proches peuvent par ailleurs être impliqués dans la rédaction du script. Cette méthode peut permettre des progrès dans la langue travaillée et une généralisation translinguistique est possible, surtout dans les textes contenant peu de cognates.



Le travail du discours peut notamment se faire grâce à des « scripts training » préparés avec l'aide d'un proche ou d'un interprète. La SBTT évoquée précédemment peut venir compléter l'intervention, en fonction des besoins du patient.

### *Stratégies pour faciliter le travail de l'anomie dans une langue que nous ne maîtrisons pas*



Parmi les stratégies existant pour faciliter le travail du discours, dans une langue que nous ne maîtrisons pas, il est par exemple possible de se servir des nombreuses vidéos disponibles en toutes les langues sur Internet comme un support à la prise en soin, pour un travail de compréhension ou de répétition. Enfin, avec l'aide de l'interprète ou d'un proche, une situation de conversation dont nous fixons les paramètres, en fonction du niveau du patient peut être proposée.

## **Interventions pour les aphasies sévères**

Nos interventions vont toujours être adaptées en fonction des possibilités du patient. Si la personne a une aphasie sévère qu'elle ne parvient par exemple pas à produire de phrases ou si elle présente une apraxie, la thérapie Melodic Intonation Therapy (MIT) est adaptée (Sarah Marchina et al., 2023). La MIT est facilement adaptable au multilinguisme puisque le travail se fait grâce à des enregistrements audios qui peuvent permettre de favoriser les productions vocales et notamment la production de phrases en plusieurs langues. L'orthophoniste peut alors prendre exemple sur les enregistrements audio pour travailler des phrases avec l'intonation particulière utilisée dans cette thérapie.

D'autre part, la thérapie Promoting Aphasia Communication Effectiveness (PACE) (Davis et Wilcox, 1981) est une méthode qui utilise la communication multimodale pour transmettre une information sans contrainte concernant la manière de le faire. Cette thérapie peut être utilisée en collaboration avec les proches du patient qui pourront

réutiliser cette technique dans la vie quotidienne. De plus, le proche pourra nous aider à faire la différence entre du jargon et un mot est dit dans langue que nous ne maîtrisons pas.

## **Intervention ciblant les fonctions exécutives**

Lorsque les déficits touchent les fonctions exécutives, les interventions ciblant ces dernières permettraient d'améliorer les processus linguistiques dans leur ensemble (Culicetto et al., 2025). Cela permet en effet de réduire les code-switching et de favoriser la généralisation translinguistique, soit les progrès simultanés dans les différentes langues, grâce à une amélioration globale des possibilités cognitives.

Globalement, lorsque les déficits langagiers sont principalement causés par des atteintes des fonctions cognitives, incluant les fonctions exécutives, mais aussi la mémoire et l'attention, le pronostique en ce qui concerne la généralisation translinguistique est meilleur que lorsque les fonctions langagières seules sont touchées de manière importante. En effet, dans ce cas, travailler sur les fonctions cognitives pourra permettre des progrès dans l'ensemble des langues, et donc une généralisation, puisque ce sont les processus cognitifs dans leur ensemble qui progresseront. De plus, lorsque nous nous retrouvons sans solution pour travailler la L1 d'une personne, une intervention en L2 uniquement, complétée par des exercices de fonctions exécutives peut se révéler pertinente.

### *Stratégies pour faciliter le travail des fonctions exécutives dans une langue que nous ne maîtrisons pas*

Concernant les stratégies pour faciliter le travail des fonctions exécutives, dans une langue que nous ne maîtrisons pas, la communication multimodale peut être utilisée, notamment pour faciliter la compréhension des consignes ou en montrant l'exemple au patient.



Lorsque nous souhaitons limiter la stimulation des fonctions langagières lors du travail des fonctions exécutives, des exercices non-verbaux peuvent comporter davantage de dimensions motrices, comme des reproductions de séquences rythmiques, ou imagées, comme l'attention ou la mémoire visuelle.

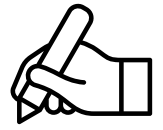
## **Précision : Alexie – Agraphie**

Cet outil se concentre sur la dimension orale de l'aphasie. Ce choix n'efface pas le fait qu'une grande proportion de personnes vivant avec une aphasie ont une alexie et/ou une agraphie associée.

Le langage écrit occupe d'ailleurs un espace important de notre quotidien : chacun d'entre nous est amené à être exposé à de nombreux messages, mails et éléments écrits sur les réseaux sociaux.

Lorsque la personne est multilingue, il arrive fréquemment que sa famille vive dans différents pays ou différents continents. La distance peut rendre le langage écrit d'autant plus important.

Lors de l'exploration des capacités de la personne prise en soin à l'écrit, il peut être utile de comparer les différentes langues, pour notamment prendre en compte les questions de transparence au niveau de la lecture et de l'écriture.



## **Intervention auprès des proches**

Les proches devraient toujours une place privilégiée dans la prise en soin en orthophonie, c'est d'autant plus vrai dans le cas d'une prise en soin multilingue.



En effet, en plus d'aider du côté linguistique, les proches pourront fournir des informations précieuses pour mieux connaître le patient, sa personnalité et son habitude ou non à prendre la place dans la conversation. De plus, d'un point de vue culturel, lorsque la personne elle-même n'est pas en mesure de le faire, le proche pourra nous renseigner sur la culture du patient et sur la manière de voir les difficultés ou les affections médicales dans ce groupe culturel (Siyambalapitiya et Davidson, 2015). En effet, dans certaines cultures, l'aphasie peut être par exemple perçue comme un fait auquel on ne peut rien changer. Cela nous permettra d'adapter la prise en soin et les explications proposées.

La collaboration avec les proches peut se faire sous forme de Communication Partner Training (CPT), qui consiste en le partage des stratégies de communication de l'orthophoniste au proche (Simmons-Mackie et al., 2010). Modéliser l'utilisation de stratégies de communication pourra permettre des échanges plus aisés. D'autant plus dans un contexte où la personne vivant avec une aphasie ne retrouve pas sa LI dans son environnement de vie, le proche devient encore plus un partenaire de communication privilégié. Cette méthode trouve toute sa place dans le cadre du multilinguisme, donner à la dyade des stratégies de communication efficaces est essentiel.

Impliquer le proche a par ailleurs l'avantage de donner l'opportunité à l'orthophoniste de démontrer les compétences de la personne vivant avec une aphasie devant son partenaire de communication principal.

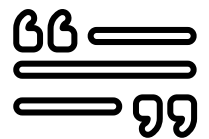
---

## **Intervention auprès de Sarah**

Pour Sarah, le choix des items à travailler en dénomination et désignation s'est fait avec sa compagne. Elle a choisi des items utiles au quotidien et a pu nous renseigner sur leurs habitudes : le couple appelle systématiquement une baguette "baguette", même dans une phrase en anglais. Il ne sera donc pas écologique d'attendre une autre réponse que "baguette" lors du travail de la dénomination en anglais. Au fur et à mesure des progrès de Sarah, ces attentes pourront changer et le mot anglais pourra être travaillé afin que Sarah puisse communiquer de manière adaptée avec des personnes anglophones uniquement.

Lors du travail de la dénomination en espagnol, une langue que nous ne maîtrisons pas, la prononciation proposée par google traduction a servi de modèle pour celle-ci.

D'autre part, Sarah ayant une aphasie non fluente, un gros travail a été fait sur la syntaxe, notamment grâce à la Melodic Intonation Therapy. Après avoir sélectionné des phrases utiles dans la vie quotidienne de Sarah, sa compagne a participé au travail en anglais.



Plus tard dans la prise en soin, le discours en espagnol a été travaillé avec un interprète.

---

## Travail à la maison

Tout domaine d'intervention confondu, la réalisation d'exercice à la maison peut être une possibilité intéressante, où les langues que nous ne maîtrisons pas peuvent être travaillées en autonomie, suivant les conseils de cette dernière (Nichol et al., 2022). Cela apporte des bénéfices notamment au niveau de la responsabilisation des patients dans leur réadaptation, aussi appelé l'autonomisation. La responsabilisation entraîne une augmentation de la motivation et du sentiment de contrôle chez les patients, qui est souvent accompagné par de meilleurs résultats d'intervention (McGrath et Schultz, 2024).

---

## Travail à la maison pour Sarah

Sarah a apprécié pouvoir travailler chez elle, elle aime se sentir actrice de sa prise en soin.



Afin de travailler sa compréhension en espagnol, nous pouvons conseiller à Sarah de regarder des vidéos destinées à des personnes apprenant l'espagnol. Les dialogues sont simplifiés et les indices non verbaux plus nombreux. Mettre les sous titres pourrait permettre de stimuler ses capacités de lecture.

D'autre part, avec sa compagne qui a assisté aux séances, Sarah peut réviser les items travaillés en dénomination grâce aux images qu'elle emporte chez elle.

## **5) Collaboration avec un interprète ou un traducteur**

### **Travail avec un interprète**

En orthophonie, nous ne devons pas seulement comprendre ce que veut dire le patient, mais aussi analyser comment il le dit, en s'intéressant notamment aux erreurs linguistiques et aux aspects culturellement inadéquats. Pour cela, le travail avec un interprète est un point clé d'une rééducation efficace avec des patients multilingues.



Pour une intervention efficace, il est utile d'organiser une rencontre avant et après afin de profiter pleinement de la présence de l'interprète. Il s'agira aussi de l'informer sur les pratiques orthophoniques et sur le vocabulaire spécifique que nous sommes susceptibles d'utiliser. Il doit être prévenu qu'il devra porter son attention sur, entre autres, la phonologie, la syntaxe et la pragmatique.

La fréquence de la collaboration avec l'interprète dépendra des besoins du patient.

#### *Pourquoi rencontrer l'interprète en amont de la rencontre avec le patient ?*

Il est important de rencontrer l'interprète en amont afin de lui transmettre des informations sur la personne elle-même, sur l'aphasie et pour l'informer sur le déroulé de la séance. Cela sera aussi le moment pour l'interprète de se familiariser avec les termes orthophoniques ou médicaux qui pourront être utilisés avec le patient. Il faudra également lui rappeler l'importance de nous rapporter toutes les erreurs du patient et de ne pas lui donner d'indices supplémentaires, qu'ils soient verbaux ou non.



Il conviendra aussi de se mettre d'accord sur la manière dont nous souhaitons que l'interprète traduise. La "traduction consécutive" semble être plus adaptée pour pouvoir être attentifs aux indices non verbaux de la personne.

#### *Pourquoi rencontrer l'interprète après la rencontre avec le patient ?*

Après la séance avec le patient et le traducteur, faire un bilan permettra d'améliorer les collaborations futures. Des ajustements pourront être évoqués pour que les patients, l'interprète et nous profitions encore plus efficacement de cette collaboration dans le futur.

L'entretien avec l'interprète avant et après n'a pas besoin d'être long pour être efficace. Il est important de parler à l'interprète lors de temps dédiés, avant et après la séance, afin d'éviter un échange de longue durée avec l'interprète devant le patient, dans une langue mal maîtrisée par le patient pourrait rendre le patient anxieux, entacher la réussite des

tests et/ou compromettre la relation soignant/patient. Il est d'ailleurs important que nous nous adressions au patient directement, en le regardant, bien que cela soit l'interprète qui lui réponde.

### *Comment trouver un interprète ?*

En fonction du pays et du lieu d'exercice, les services d'interprétariat sont disponibles sous différentes modalités : l'échange peut par exemple se faire uniquement par téléphone ou en prenant rendez-vous une semaine à l'avance. Dans certains pays, il est également possible d'être mis en contact avec un interprète grâce aux ambassades ou grâce à des associations de patients ou agissant pour les personnes immigrées.



En France, il existe par exemple l'association Inter Service Migrants (ISM) Interprétariat sur Paris et le Réseau Louis Guilloux sur Rennes, qui proposent toutes deux un service d'interprétariat médico-social (Haute Autorité de Santé, 2017).

D'autre part, lorsque le recours à un interprète n'est pas possible, l'utilisation d'une traduction par synthèse vocale peut être utile, et permet de contourner l'écrit. Cependant si la personne vivant avec une aphasie est âgée, la compréhension d'une voix enregistrée comme celle d'une synthèse vocale, peut être plus difficile que la voix naturelle.

---

### **Travail avec Sarah et un interprète**

Si l'on considère que nous ne parlons ni anglais ni espagnol, il pourrait être utile de faire appel à deux interprètes : un en espagnol, si possible d'origine mexicaine, et un en anglais si possible d'origine américaine. Le choix arbitraire fait ici a été de faire appel à un interprète en espagnol uniquement et d'inclure la compagne de Sarah dans la prise en soin pour l'anglais.

L'interprète est venu une séance par semaine pour travailler l'espagnol. L'ensemble de la séance était alors traduite : les phrases d'accueil, les consignes et les interactions lors des exercices proposés.

Environ une séance par mois était consacrée à la discussion sur ses ressentis en vie quotidienne et à la mise à jour des objectifs importants à travailler pour elle. Dans le cas de Sarah, cela pouvait aussi être fait en anglais, son autre langue maternelle à l'aide de sa compagne. Sarah a toutefois préféré se confier sur ses difficultés quotidiennes en espagnol avec l'interprète pour ne pas risquer de provoquer des ressentis négatifs chez sa compagne qui est aussi son aidante au quotidien.



## Traductions et adaptations

La traduction est aussi un domaine à investiguer ; lorsque nous possédons du matériel essentiellement en français, ce matériel peut être traduit et adapté, pour être utilisé avec un patient non francophone.



Cette traduction peut se faire en ligne ou en faisant appel à un traducteur. Le recours à ce dernier est intéressant pour les aspects culturels : éviter les références spécifiquement françaises qui ne seraient pas connues dans certains pays. Faire appel à un traducteur demande cependant un grand investissement si le but est simplement de traduire un ou deux exercices.

Traduire des exercices soi-même n'est pas toujours facile et peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre de patients concernés (lieu d'exercice cosmopolite ou non) et de la langue recherchée. Dans le cas de la traduction d'exercices, attention cependant à adapter les objectifs linguistiques. Ils ne pourront pas être les mêmes après traduction (distracteur phonologiques, rimes ou paires minimales par exemple) et aux incohérences culturelles qui peuvent subvenir pour certains items. La traduction simple est un bon début mais n'est pas suffisante pour adapter les tests et matériels linguistiquement et culturellement.

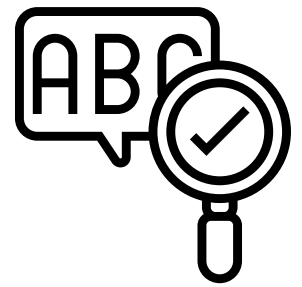
### *A quoi correspond la traduction VS adaptation?*

Traduire, c'est transposer les mots. Adapter, c'est tenir compte de la culture, des spécificités linguistiques, et du contexte d'usage pour garantir une prise en charge efficace et respectueuse. Plusieurs notions sont à prendre en compte :

- Différences syntaxiques : Les langues peuvent avoir des structures grammaticales très variées (Exemple : Ordre des mots (SVO en français vs SOV dans d'autres langues))
- Anomie et complexité phonologique : Certaines langues ont des mots plus longs ou des structures phonologiques plus complexes. Le type d'erreurs peut varier en fonction de la langue cible.
- Lecture et écriture : Opacité linguistique : Certaines langues ont une correspondance graphème-phonème régulière (ex. espagnol), alors que d'autres sont plus opaques (ex. français ou anglais). Ces différences influencent les stratégies d'évaluation et d'intervention.
- Pragmatiques culturelles : Les comportements langagiers (gestes, politesse, manière de raconter une histoire) peuvent varier largement entre les cultures.

### *Principes clés pour adapter du matériel*

D'abord, il convient de se renseigner sur la langue cible, notamment sur sa phonologie, son système d'écriture, sa syntaxe et ses normes culturelles. Cela pourrait permettre d'identifier les spécificités pouvant influencer les performances linguistiques. Ensuite, travailler avec des locuteurs natifs connaissant la culture de la personne, comme un proche ou un interprète, pourrait permettre de faire valider la pertinence linguistique et culturelle des outils ou contenus que nous avons adaptés. Il convient aussi de considérer les caractéristiques du patient : Quelle est la langue dominante ? Celle apprise en premier ? Celle le plus souvent utilisée au quotidien ? Enfin, lorsqu'un matériel adapté nous semble prêt, le tester avec un patient permettra de vérifier que l'adaptation convienne et de l'ajuster si besoin.



## **6) Pistes de réflexion**

Pour finir, lorsque nous recevons un patient appartenant à un groupe culturel différent du nôtre, il peut exister des biais inconscients qui nous influencent, malgré nous, à ne pas prendre en soin toutes les personnes de la même façon. En effet, certaines populations peuvent se sentir peu écoutées, voire marginalisées lorsqu'elles consultent un professionnel de santé (Warren, 2025). Outre la langue, certaines personnes multilingues peuvent parfois avoir d'autres différences avec la majorité de la population du pays où se déroulent les soins. En effet, l'intersectionnalité, ou l'accumulation des marginalisations, comme une catégorie socio-professionnelle défavorisée et/ou la non-possession de la citoyenneté, peuvent amener des difficultés s'ajoutant les unes aux autres (Conseil canadien pour les réfugiés, 2025).



Ces constats semblent pouvoir nous encourager à développer notre sensibilité à la culture de nos patients, permettant ainsi de proposer des soins plus équitables et plus inclusifs, impactant positivement les performances des personnes issues du multiculturalisme (Warren, 2025).

**Références**